

Otitis externa maligna (en diabéticos e inmunodeprimidos)

1. Introducción y relevancia clínica

La **otitis externa maligna (OEM)**, también llamada **osteomielitis del hueso temporal**, es una **infección necrosante grave del conducto auditivo externo (CAE)** que se **extiende a la base del cráneo**, afectando el hueso temporal y estructuras vecinas.

Fue descrita por primera vez por Chandler en 1968, quien la denominó “maligna” por su curso agresivo y elevada mortalidad si no se trata oportunamente.

Aunque infrecuente, es una **emergencia otorrinolaringológica**.

Afecta principalmente a **pacientes diabéticos, ancianos o inmunodeprimidos** (VIH, cáncer, quimioterapia, corticoides prolongados). En estos grupos, incluso una otitis externa banal puede evolucionar hacia una infección invasora.

El agente etiológico más común es **Pseudomonas aeruginosa**, responsable de más del **90% de los casos**. La mortalidad actual, pese al tratamiento antibiótico moderno, puede alcanzar un **15–20%**, especialmente si existe compromiso de pares craneales.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La OEM representa una **continuidad patológica entre una otitis externa aguda y una osteomielitis de la base del cráneo**.

1. **Infección inicial del CAE** (habitualmente por *Pseudomonas*).
2. En diabéticos, la **angiopatía microvascular** y la **hiperglicemia** reducen la defensa tisular.
3. El germen invade el **tejido subepitelial y el cartílago** del CAE.
4. Posteriormente se extiende al **hueso temporal, apófisis mastoides, y base del cráneo**.
5. Puede comprometer **pares craneales** (VII, IX, X, XI, XII) por extensión perineural.

Factores predisponentes:

- Diabetes mellitus descompensada.

- Inmunosupresión (VIH, leucemia, quimioterapia).
 - Uso prolongado de corticoides o antibióticos tópicos.
 - Otitis externa mal tratada.
 - Traumatismos locales (cotonitos, audífonos, audífonos moldeados).
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas principales

El cuadro es **insidioso y progresivo**, con síntomas que persisten a pesar del tratamiento convencional para otitis externa.

Síntoma	Características
Otalgia intensa y profunda	Dolor severo, persistente, de predominio nocturno. No cede con analgésicos.
Otorrea purulenta crónica	De mal olor, persistente pese a gotas antibióticas.
Hipoacusia conductiva o mixta	Por edema y compromiso timpánico secundario.
Prurito y sensación de plenitud	Habitual en etapas iniciales.

3.2 Signos al examen físico

- **Edema y eritema difuso del CAE**, con tejido de **granulación friable** en el fondo (signo característico).
- Dolor intenso al mover el pabellón o al introducir el espéculo.

- **Secreción verdosa** con olor a Pseudomonas.
- En etapas avanzadas: **dolor retroauricular, tumefacción mastoidea o parálisis facial periférica (VII PC).**

3.3 Compromiso de pares craneales (en orden de frecuencia)

1. **VII par (facial)** → parálisis facial periférica (signo de extensión ósea).
2. **IX, X, XI, XII pares** → disfagia, disfonía, desviación lingual.
3. **V par** → dolor facial.
4. **VI par** → diplopía (por afectación del seno cavernoso).

3.4 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferencias principales
Otitis externa aguda simple	Dolor menor, sin tejido de granulación, responde a tratamiento tópico
Mastoiditis	Fiebre, otorrea con antecedente de otitis media, abombamiento retroauricular
Colesteatoma	Otorrea fétida crónica pero sin dolor severo, erosión ósea focal
Carcinoma del CAE	Masa polipoidea, sangrado fácil, biopsia positiva para neoplasia

Dato clave para EUNACOM:

La presencia de **dolor intenso nocturno + tejido de granulación en el CAE + diabetes = otitis externa maligna** hasta demostrar lo contrario.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico es **clínico** pero requiere **confirmación radiológica y microbiológica**.

Examen	Hallazgos / Utilidad
Cultivo de secreción del CAE	Identifica <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (germen clásico) o resistencia antibiótica
TAC de peñasco o mastoides con contraste	Engrosamiento óseo, erosión cortical o compromiso mastoideo
RMN de base de cráneo	Evalúa extensión de partes blandas, pares craneales y senos venosos
Gammagrafía con Tecnecio-99 o Galio-67	Detecta actividad osteomielítica (útil para seguimiento del tratamiento)
Hemograma, VHS, PCR	Elevación de marcadores inflamatorios
Glicemia y HbA1c	Evaluar control metabólico del paciente diabético

Criterios diagnósticos de OEM (según Chandler y MINSAL):

1. Dolor severo persistente e hipoacusia conductiva.
 2. Otorrea purulenta fétida crónica.
 3. Tejido de granulación en el CAE.
 4. Diabetes o inmunosupresión.
 5. Evidencia radiológica de osteomielitis del hueso temporal.
 6. Aislamiento de *Pseudomonas aeruginosa*.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El tratamiento debe ser **agresivo y prolongado**, combinando antibióticos sistémicos, control metabólico y cuidados locales.

5.1 Medidas generales

- **Hospitalización inicial** para control y manejo interdisciplinario (ORL + Medicina Interna + Infectología).
 - **Control estricto de glicemia** en diabéticos (insulinoterapia).
 - **Evitar manipulación local o lavado** del oído hasta estabilización.
 - **Analgesia adecuada**: AINEs o tramadol en dolor severo.
-

5.2 Tratamiento antibiótico sistémico

Antibiótico de elección:

- **Ciprofloxacino EV** 400 mg cada 12 h por 2 semanas, luego **VO 750 mg cada 12 h** por un total de **6–8 semanas**.
 - Activo contra *Pseudomonas* y con buena penetración ósea.

Alternativas (según sensibilidad y contexto hospitalario):

Situación	Fármaco alternativo	Comentario
Cepas resistentes o evolución tórpida	Ceftazidima 2 g EV cada 8 h	Antipseudomónico potente
Paciente con alergia a quinolonas	Piperacilina/tazobactam 4.5 g EV cada 6 h	Cobertura amplia

Infección fúngica asociada Voriconazol o anfotericina B EV Bajo supervisión infectológica

Duración del tratamiento:

Mínimo **6 a 8 semanas**, guiado por resolución clínica y normalización de **VHS/PCR**.

El tratamiento prolongado es esencial para evitar recaídas.

5.3 Tratamiento local

- Limpieza suave del conducto (microaspiración) realizada por ORL.
 - En casos con edema severo, uso de **mecha con antibiótico tópico (ciprofloxacino + corticoide)** durante 24–48 h.
 - Evitar irrigaciones o gotas ototóxicas (aminoglucósidos) si hay sospecha de perforación.
-

5.4 Cirugía (rara vez necesaria)

Indicada solo en:

- Abscesos localizados o necrosis extensa.
- Fracaso del tratamiento médico prolongado.
- Necesidad de desbridamiento óseo o drenaje de tejido necrótico.

La cirugía se limita a **debridamiento conservador**, evitando daño al nervio facial o estructuras críticas.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación

Mecanismo / Comentario

Parálisis facial periférica (VII par)	Invasión perineural del nervio facial
Compromiso de pares craneales bajos (IX–XII)	Extensión a base de cráneo
Trombosis del seno sigmoideo o cavernoso	Diseminación intracraneal
Absceso cerebral o meningitis	En casos avanzados
Osteomielitis difusa del cráneo	Continuación del proceso infeccioso
Recurrencia	Control inadecuado del foco o diabetes mal compensada

Pronóstico:

- Mortalidad actual: 10–20%.
- Recaídas en 15–25% de los casos si tratamiento es insuficiente.
- La parálisis facial es reversible en 50% con manejo precoz.
- El control metabólico es el principal factor pronóstico.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. Dolor nocturno intenso + diabetes + tejido de granulación en el CAE = **Otitis externa maligna**.
2. *Pseudomonas aeruginosa* es el germen responsable en >90% de los casos.

3. **Ciprofloxacino EV + VO prolongado** (6–8 semanas) es el tratamiento de elección.
 4. No confundir con otitis externa simple: esta última responde a antibióticos tópicos en pocos días.
 5. La **presencia de parálisis facial periférica** indica extensión ósea.
 6. El **TAC y la RMN** son esenciales para evaluar extensión.
 7. Un buen control glicémico es tan importante como el antibiótico.
-

Errores comunes

- Tratar con gotas tópicas aisladas (ineficaces en OEM).
 - No realizar imagenología en dolor persistente.
 - No controlar la glicemia en pacientes diabéticos.
 - No completar el tratamiento antibiótico prolongado.
 - Ignorar tejido de granulación como signo de alarma.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **otitis externa maligna** es una **osteomielitis del hueso temporal** causada por *Pseudomonas aeruginosa*, que afecta principalmente a **diabéticos e inmunodeprimidos**.
2. Se presenta con **dolor intenso, otorrea fétida persistente y tejido de granulación** en el CAE.
3. El diagnóstico se confirma con **TAC o RMN** y **cultivo positivo para Pseudomonas**.
4. El tratamiento requiere **ciprofloxacino EV + VO por 6–8 semanas**, más **control metabólico estricto**.
5. Las complicaciones más graves incluyen **parálisis facial, trombosis venosa y absceso cerebral**.

6. El **control radiológico y de marcadores inflamatorios** guía la duración terapéutica.
7. En todo paciente diabético con otitis dolorosa que no mejora, **sospechar otitis externa maligna**.